

AFMCP Chap6 패널 심장질환 임상 진주 요약

Dr. Carter / Dr. Bhojraj / Dr. Druz 패널 핵심 조언

질환별 핵심 임상 진주 정리

대사심혈관 증후군

- Druz: 정신·감정·영적 요인 + 스트레스·수면 → 가장 과소평가된 매개 요인
- Bhojraj: 민족별 진단 기준 숙지 (아시아인 기준 낮음!), 환자 배경 고려
- Carter: BMI 넘어서 신체계측 다양화 + 식품 일지로 실제 식이 파악

고혈압

- Carter: ① 초가공 식품 제거가 최우선 ② 나트륨 ↓보다 칼륨 ↑ 식품에 집중
- Bhojraj: 심박 변이도(HRV)로 교감신경 평가 → 호흡 운동이 1차 비약물 치료
- Druz: 불안정 혈압 = 인슐린 저항성 초기 징후 가능 → 대사심혈관 평가 연계
- 팀: 혈압 측정 → 30초 심호흡 → 혈압 재측정 (환자 동기 부여에 강력)

이상지질혈증

- Bhojraj: LDLP·소밀도LDL 포함 포괄적 지질 평가 = 이제 표준 치료 수준
- Druz: 식사 시간·공복 간격 탐색; 12시간 공복만으로 지질 10~20% 개선 가능
- Carter: 환자에게 심장마비 기전 설명 → 포괄 검사와 연결
- 진행자: 중성지방 수치 인식 높이기, 칼로리 음료 제한이 가장 쉬운 첫 개입

관상동맥 질환 (CAD)

- Druz: '죽상경화염' 개념 → 칼슘 점수 발견 즉시 약물 아닌 근본 원인(염증) 추적
- Bhojraj: 환경 독성 노출 (고속도로 2마일 이내 거주 → CAD 위험 ↑) 병력청취
- Carter: TMAO 등 장 건강 지표 일상적 검사 권장

심부전

- Bhojraj: 수축기 심부전 = 분자 생체에너지 문제 → 식이·영양·생활습관으로 심근 미토콘드리아 건강 개선
- Carter: 심부전 환자에서 미량영양소 결핍(Se·Cu·Mg·Zn) 자주 발견 → 보충 중요
- Druz: HFpEF(보존 박출률 심부전) = 비만 관련 = 대사심혈관 기능이상 상태

말초혈관 질환 (PVD)

- Carter: 걷기 프로그램 → 측부 혈류 + 소혈관 혈류 개선
- Druz: 항염증 + 인슐린 안정화 식단 (약물·시술 선택지 적음)
- Bhojraj: PFAS·미세플라스틱 노출 감소 (NEJM 2023/24: 경동맥 플라크 내 미세플라스틱 발견)

공통 패턴 및 임상 적용 포인트

- 모든 심혈관 질환의 공통 근본 원인: 염증·산화 스트레스·인슐린 저항성
- 매트릭스 순환 접근: 어느 노드에서든 발생한 염증이 심혈관에 영향
- 환경 독소 노출 병력청취가 모든 심혈관 질환에서 필수
- 중성지방/칼로리 음료가 가장 쉽고 빠른 개입 포인트
- 협진팀 활용: 약사(심혈관약 감량), 정신건강 전문가, 영양사